

Fecha Última Actualización: 17-02-2022 22:04:17

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Maria Soledad Cornejo Painemilla
Edad : 66a 7m 5d
Dirección : Oscar Bonilla 0197

Rut : 7.583.310-5
Fecha Nacto: 12/07/1955
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : A139280
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 3091 1521

N° Epicrisis
296665

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utim

Fecha Ingreso : 18/01/2022 08:14

Días Estadía: 30

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 17/02/2022 22:02

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

dificultad respiratoria

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Datos del Paciente

Nombre : María Soledad Painemilla

Edad : 66 años

RUT : 7.583.310-5

FI HSR : 18-01-22

FI Sala básica : 19/01/2022

FI UTIM : 25/01/2022

FI UCI: 27/01/2022

Antecedentes:

Médicos:HTA, DM2, Crisis de pánico, Artrosis, Ca de mama I° - Lesión papilar intraductal. Mastectomía parcial. Insuficiencia cardiaca. Obesidad (IMC 44), Daño hepático crónico, EcoAbd 12-10-21 con signos de DHC esplenomegalia y ascitis moderada. Colelitiasis y esteatosis hepática moderada.

Quirúrgicos: MP septiembre 2021, cesárea, Fx rótula I°

Fármacos: Propanolol 20 mg cada 12 horas, Furosemida 40 mg cada 24h, Maltofer 1 cada 24 horas, Sertralina 100 mg al día, Losartán

Alergias: no

Hábitos: OH (-) TBQ (-) Otras drogas (-)

Sociales:

Inmunización: Sinovac 2 dosis, Pfizer 1 dosis

Hospitalizaciones: diciembre 2021 - pancitopenia en estudio

Motivo de Ingreso: disnea

Paciente con antecedentes descritos, en buenas condiciones generales hasta 2 meses previos al ingreso cuando comienza con disnea de esfuerzo progresiva asociado a aumento de volumen de EEII progresivo. Se agregó además nictura (2-3 ep día), disnea paroxística nocturna y palpitaciones rápidas ocasionales. Consulta por progresión de disnea hasta mínimos esfuerzos.

Durante estadía en SU: se constató FC 69 lpm PA 128/77 mm Hg T°36.6°C saturando 95% con Fio2?. Al examen físico destacó uso de musculatura accesoria, disnea a pequeños esfuerzos y edema de EEII. Exámenes de ingreso destacó:

crea: 0.80 BUN: 19.8 Na: 140 K: 3.60 cl: 107

Fecha Epicrisis : 17/02/2022 22:04

Página 1 de 4

Fecha Última Actualización: 17-02-2022 22:04:17

Página 2 de 4

·PCR: 18.5 Hb: 9.2 hcto: 30.2 leuc: 3820 RAN: 3000 RAL: 2100 Monocitos: 700 plq: 99.000
·alb: 2.5 Bil t: 1.30 Bil d: 0.57 GOT: 64 GPT: 32 FA: 130 GOT: 64 GPT: 32 glu: 73 LDH: 547
·GSV: PH: 7.40 Pco2: 39.8 Hco3: 24.1
·INR: 2.07 TTPK: 43.2

Se inició terapia depletiva y medicamentos de uso habitual. Se trasladó a medicina básica para continuar manejo.

Evolucion en sala basica.1

Hemodinámico-Cardiológico: se mantuvo con signos de VEC mal distribuido, recibiendo terapia depletiva (aunque con suspensión intermitente en relación a hipokalemia) y volemicación con coloides.

Se realizó EcoTT que evidenció (24-01) FE 65% dilat Moderada AI y leve de AD, estenosis aórtica moderada, insuf mitral leve, PSAP 35 mm Hg, dilatación de Ao ascd.

El 25/01 presentó un episodio de insuficiencia respiratoria súbita. Se realizó EKG que mostró hemibloqueo izquierdo anterior y BCDR. Se realizó curva de TpUs que resultó positiva (TpUS 41 a 455) y AngioTC de tórax que muestra signos de edema intersticial, derrame pleural izquierdo, sin TEP. Evaluada por cardiología se interpreta como IAM tipo 2, con indicación de estudio coronariográfico en diferido.

Respiratorio: durante hospitalización con requerimientos intermitentes de oxígeno. Se habría propuesto mantener CPAP PEEP 6 que resulta frustra por mala tolerancia de paciente. El 25-01 presentó episodio de disnea súbito con aumento en requerimientos de oxígeno seguido de peak febril de hasta 38.9°C y taquipnea que cede parcialmente a terapia farmacológica. Se traslada a UTIM con requerimientos de oxígeno 3 lt saturando 98%.

Infeccioso: ingresa con parámetros inflamatorios bajos y mantuvo requerimiento de CUP para monitorización de diuresis. Por sospecha de sd nefrítico se realizó estudio en orina del que destacó sedimento de orina inflamatorio y UC positivo para K oxytoca (21-01). Se mantuvo en regulares condiciones generales, con tendencia a la hipotensión y requerimiento de volemicación con coloides. El 25-01 durante la mañana presentó peak febril de hasta 38.9°C precedido por aumento en requerimientos de oxígeno y taquipnea. Se inició ceftriaxona 2 gr y terapia antipirética previa toma de nuevos cultivos.

Además SOC con piocitos (24-01)

Gastroenterológico: estudio ambulatorio diciembre 2021 compatible con DHC. Por sub problemas

·Etiológico: se realizó serología viral que resulta negativa. Registra Ecoabdominal 12-10-21 con signos de DHC esplenomegalia y ascitis moderada. Colelitiasis y esteatosis hepática moderada.

·EH: EH G1 (inatención) se mantuvo con laxantes osmóticos

·VE: sin registro de EDA

·HCC: sin evidencia ecográfica

·Ascitis: se realizó estudio de líquido ascítico (20-1) compatible con ascitis dependiente de hipertensión portal. Inició manejo con terapia con Espironolactona 100 mg.

Nefrológico: por historia de orinas espumosas se inició estudio

·proteinuria aislada 1.1 g/L

·IPC 0.6, SU >50, GR 0-3 GB

·Orina completa con piuria, GR>100 - GB >100

·C3 55 C4 11 FR <10

·EFP - MPO - ANCA - ANA - PR3 (20-01) pendientes.

Se mantuvo con diuresis conservada sin alteración de función renal y con tendencia a hipokalemia que requirió reposición endovenosa.

Hematológico: desde el ingreso se constató anemia moderada microcítica VCM 71. Se realizó estudio con hemograma que evidenció Hb 8 VCM 77 plaq 92000 GB normales y perfil de hierro compatible con anemia de enfermedades crónicas con un componente ferropénico (Fe 22 TIBC 215 %SatT 10%). Se planteó inicio de suplementación con Hierro sacarato que quedó diferida por intercurencia infecciosa.

El 25/01 se traslada a UTIM donde evoluciona con mejoría en lo ventilatorio, apoyando con VNI pero con mala tolerancia por lo que se pasa a CNAF, parcialmente tolerado. En lo hemodinámico se apoya con DVA en dosis bajas y aportes de albumina. Se suspende terapia depletiva dado cuadro inflamatorio en evolución.

En lo infeccioso se escala a terapia de segunda línea con vancomicina/imipenem. En HC se aísla SAMS por lo que se ajusta esquema a cloxacilina + imipenem.

Fecha Epicrisis : 17/02/2022 22:04

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 17-02-2022 22:04:17

Página 3 de 4

Sin deterioro renal, sin alteración electrolítica significativa.

Paciente evoluciona con mayor compromiso ventilatorio que no responde a VNI por lo que se decide intubar y conectar a VMI. Se traslada a UCI para continuar tratamiento.

Diagnósticos:

1. Insuficiencia respiratoria - EPA
- i. Insuficiencia cardíaca con FE conservada descompensada
- ii. derrame pleural izquierdo leve
2. Sepsis de foco urinario
- a. ITU alta por K oxytoca MS
- b. Bacteriemia por SAMS
3. DHC descompensado
- a. EH G2 - sin EDA - Ascitis moderada - sin HCC
2. Anemia de enfermedades crónicas con componente ferropénico
3. Hematuria en estudio obs no glomerular
4. Antecedentes HTA - DM2 - Crisis de pánico - Artrosis - Obesidad (IMC 44), Ca de mama I° - Lesión papilar intraductal. Mastectomía parcial

Evolución en UCI:

HDN: inestable desde su ingreso, con VEC muy aumentado. Se inicia terapia depleitiva con furosemida, con respuesta parcial. En relación a hemorragia digestiva baja secundaria a hemorroide sangrante requiere volemicación con cristaloides, albumina, hemoderivados y DAV en dosis altas llegando hasta adrenalina a 0.4 mcg/kg/min y noradrenalina hasta 0.7 mcg/kg/min. Paciente presenta PCR en asistolia el 17/02/2022.

Respiratorio: buena respuesta a terapia depleitiva inicial, se logran BH negativos y mejoría del intercambio respiratorio pero no se logra weaning dado compromiso de conciencia persistente.

Infeccioso: múltiples hit infecciosos durante estadía en UCI, último hit bacteriemia por E. faecium y A. baumannii, en tto con Linezolid y AMS. Buena respuesta inicial, con quiebre de curva térmica y PCR a la baja.

Renal: falla renal aguda en contexto de DHC, sin requerimientos de HD.

Hepático: daño hepático avanzado, durante estadía cursa con encefalopatía persistente y coagulopatía con INR hasta 5.9. Dado sangrado activo se intenta corrección con Octaplex y transfusión de hemoderivados. Se realiza colonoscopia que muestra paquete hemorroidal de 10mm con sangrado en napa. Se realiza packing rectal por coloproctología el 17/02. Paciente persiste con sangrado, con requerimientos de DVA al alza. Dado patologías de base y elevado riesgo quirúrgico se decide manejo médico full, pero paciente fallece a las 20:15 horas del 17/02/2022

Diagnóstico de Egreso

Insuficiencia cardíaca izquierda descompensada - EDEMA PULMONAR AGUDO
Daño Hepático Crónico - ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA
Shock séptico - Bacteriemia por E. Faecium y E. baumannii
Hemorragia Digestiva Baja - Hemorroidal

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J: NO

Paciente fallecido

Plan Post Alta

Paciente fallecido

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

Fecha Epicrisis : 17/02/2022 22:04

Página 3 de 4



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 17-02-2022 22:04:17

Página 4 de 4

INTERNO

Becado/Residente

Fabian Aguilera Mauna

Médico Tratante (Staff)